

PETIÇÃO TR CÍVEL Nº 5109547-75.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

REQUERENTE: MIGUEL AGOSTINHO DE ALMEIDA COSTA

RÉU: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RÉU: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RÉU: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

REQUERIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DPU

SAÚDE. TEMA 106 DO C. STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE REGISTRO DO MEDICAMENTO NA ANVISA, OBSERVADOS OS USOS AUTORIZADOS PELA AGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Condene a Recorrente nas verbas sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mas suspendo em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Publique-se. Intime-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2025.

5109547-75.2024.4.02.5101

510015369214 .V6

PETIÇÃO TR CÍVEL Nº 5109547-75.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

REQUERENTE: MIGUEL AGOSTINHO DE ALMEIDA COSTA

RÉU: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RÉU: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RÉU: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

REQUERIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DPU

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela parte autora em face da decisão proferida no evento 23, DESPADEC1, *verbis*:

"Trata-se de ação proposta por Miguel Agostinho de Almeida Costa, representado por Suzy Geralda Agostinho, contra a União, o Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro, com pedido de concessão da tutela provisória de urgência, objetivando a condenação dos réus ao fornecimento do medicamento Aripiprazol 10mg, para o tratamento da doença que o acomete.

Breve relatório. Decido.

O juiz poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida na petição inicial quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso, os documentos dos autos não demonstram de plano a necessidade iminente do uso do medicamento pleiteado. Na verdade, o formulário médico do evento 1 - ANEXO2, fl. 12 afirma que não resta configurada a urgência da situação.

Desse modo, entendo que inexistem elementos que permitam concluir pela urgência no tratamento com a medicação ora postulada, razão pela qual, neste juízo de cognição sumária, mostra-se forçoso o indeferimento do provimento liminar pretendido.

Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, com fulcro no art. 4º, da Lei nº 10.259/01, c/c art. 300, do Código de Processo Civil.

Citem-se os réus para apresentar contestação no prazo legal, contado em dias úteis, e instruindo a peça com os documentos necessários ao deslinde do feito.

Suspenda-se o curso do processo durante o prazo para resposta ou até apresentação desta, tendo em vista que se trata de prazo superior a 30 (trinta) dias corridos.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça.

Defiro o pedido de prioridade dos atos processuais em função da idade.

Intime-se a DPU e o MPF."

É o breve relatório.

VOTO

Dispõe o Enunciado 13 do CNJ: "*Nas ações de saúde que pleiteiam o fornecimento de medicamentos, produtos ou tratamentos, recomenda-se, sempre que possível, a prévia oitiva do gestor do Sistema Único de Saúde – SUS, com vistas a, inclusive, identificar solicitação prévia do requerente, alternativas terapêuticas e competência do ente federado, quando aplicável (Saúde Pública e Suplementar). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)*".

O NAT emitiu parecer nos seguintes termos:

PARECER TÉCNICO/SES/SJ/NATJUS-FEDERAL Nº 1923/2024

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2024.

Processo nº 5075471-25.2024.4.02.5101,
ajuizado por **Miguel Agostinho de Almeida Costa**, representado por **Suzy Geralda Agostinho**.

O Autor, 13 anos (DN: 12/04/2011), apresenta **transtorno do espectro autista**, com fala funcional e **deficiência intelectual** moderada associada ao **transtorno de déficit de atenção e hiperatividade** moderado. Fez uso de Risperidona 1mg e 2mg/dia, dos 04 aos 13 anos de idade, porém falhou a apresentar agressividade, compulsão alimentar e insônia. Assim foi prescrito, em uso contínuo, o medicamento **Aripiprazol 10mg** – tomar 1 comprimido de manhã e de noite (Evento 1_ ANEXO2, páginas 10 a 21).

Informa-se que o medicamento **Aripiprazol** **não apresenta indicação descrita em bula**¹ para o tratamento do **transtorno do espectro do autismo** e **transtorno de déficit de atenção com hiperatividade**, quadro clínico apresentado pelo Autor, conforme relatado em documentos médicos. Assim, **sua indicação, nesse caso, configura uso off label**.

Ainda sem tradução oficial para o português, usa-se o termo *off label* para se referir ao uso diferente do aprovado em bula ou ao uso de produto não registrado no órgão regulatório de vigilância sanitária no País, que, no Brasil, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Engloba variadas situações em que o medicamento é usado em não conformidade com as orientações da bula, incluindo a administração de formulações extemporâneas ou de doses elaboradas a partir de especialidades farmacêuticas registradas; indicações e posologias não usuais; administração do medicamento por via diferente da preconizada; administração em faixas etárias para as quais o medicamento não foi testado; e indicação terapêutica diferente da aprovada para o medicamento².

Excepcionalmente a ANVISA pode autorizar o uso de um medicamento para uma indicação que não conste em bula, conforme previsto no Artigo 21 do Decreto 8.077, de 14 de agosto de 2013³. Contudo, atualmente, não há autorização excepcional pela ANVISA para o uso *off label* do medicamento **Aripiprazol** no tratamento do **transtorno do espectro do autismo** e **transtorno de déficit de atenção com hiperatividade**.

Informa-se que, a Lei nº 14.313, de 21 de março de 2022⁴, autoriza o uso off label de medicamento em que a indicação de uso seja distinta daquela aprovada no registro na Anvisa, desde que seu uso tenha sido recomendado pela Conitec, demonstradas as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança, e esteja padronizado em protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde.

De acordo com literatura consultada o Aripiprazol tem eficácia no tratamento de distúrbios comportamentais, incluindo irritabilidade, hiperatividade, fala inadequada e comportamento estereotipado encontrados em crianças e adolescentes com transtorno do espectro do autismo. No entanto, não conseguiu melhorar a letargia/retraimento social em tais pacientes. A presente evidência também indica que é seguro, aceitável e tolerável em tal tratamento. Mais estudos bem definidos e com amostra grande devem ser conduzidos para garantir esses achados⁵.

Os antipsicóticos de segunda geração surgem como opção terapêutica no tratamento para o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), principalmente, na redução dos sintomas, como impulsividade agressividade déficit de atenção e hiperatividade e irritabilidade. Nessa categoria, os medicamentos mais prescritos são o Aripiprazol e a Risperidona⁶.

Desta maneira, este núcleo entende que há embasamento científico que respalde o uso do medicamento pleiteado Aripiprazol no tratamento da condição clínica do Autor.

No que tange à disponibilização pelo SUS do medicamento pleiteado insta mencionar que Aripiprazol 10mg não integra nenhuma lista oficial de medicamentos (Componentes Básico, Estratégico e Especializado) para dispensação no SUS, no âmbito do Município e do Estado do Rio de Janeiro.

Para o tratamento do Autismo, o Ministério da Saúde atualizou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo⁷, preconizou os seguintes fármacos: Risperidona: solução oral de 1mg/mL (para doses que exigem frações de 0,5mg); comprimidos de 1, 2 e 3mg. Por conseguinte, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), atualmente disponibiliza, no CEAF, o medicamento Risperidona 1mg e 2mg.

Serão incluídos no referido Protocolo pacientes com diagnóstico de TEA e com comportamento agressivo grave dirigido a si ou a terceiros, com baixa resposta ou adesão às intervenções não medicamentosas. O uso de psicofármaco (Risperidona) combinado com o tratamento não medicamentoso se apresenta como uma estratégia superior ao tratamento medicamentoso de forma isolada. Assim, o uso de antipsicótico deve ser considerado um complemento às intervenções não farmacológicas nas pessoas com TEA e não a única ou principal estratégia de cuidado. Além disso, o PCDT do Ministério da Saúde não prevê outra linha de

tratamento farmacológico em casos de refratariedade ao tratamento com o medicamento padronizado Risperidona⁷.

Cabe ressaltar ainda que o PCDT faz referência ao Aripiprazol, mencionando que no Brasil, a indicação para TEA, contudo, não está aprovada em bula. Tendo em vista seu uso em outros países, foi conduzida revisão sistemática da literatura. A comparação entre Aripiprazol e Risperidona mostrou com baixa certeza que não há diferença significativa entre os medicamentos, quando comparada a melhora dos sinais e sintomas do comportamento agressivo no TEA. Em relação aos desfechos de segurança, a certeza da evidência foi muito baixa para todos os desfechos por considerar somente um ECR, que apresenta falhas metodológicas. Assim, o medicamento preconizado neste Protocolo é a Risperidona⁷.

Cabe ainda resgatar o relato médico (Evento 1_ANEXO2, páginas 10 a 21), que o Autor “... Fez uso de Risperidona 1mg e 2mg/dia, dos 04 aos 13 anos de idade, porém falhou ao apresentar agressividade, compulsão alimentar e insônia”. Assim, cumpre informar que o Autor já utilizou o medicamento Risperidona disponibilizado pelo SUS.

Para o tratamento do transtorno do déficit de atenção/hiperatividade (TDAH), o Ministério da Saúde publicou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade⁸, através da Portaria Conjunta Nº 14, de 29 de julho de 2022. No que tange ao gerenciamento do TDAH, dada à complexidade dessa condição, preconiza-se a intervenção multimodal, incluindo intervenções não medicamentosas (precisamente intervenções cognitivas e comportamentais) para melhora dos sintomas deste transtorno, no controle executivo e no funcionamento ocupacional e social. Enfatiza que as intervenções psicossociais, comportamentais e de habilidades sociais são essenciais para crianças e adultos com TDAH. Dentre as intervenções psicossociais, destaca-se a terapia cognitivo comportamental. Não foram recomendados tratamento com medicamentos, por fraca evidência². Assim, o SUS não oferta medicamentos para tratamento do TDAH.

Elucida-se que o medicamento Aripiprazol possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Contudo, até o momento não foi submetido à análise da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Ministério da Saúde (CONITEC-MS)⁹

Convém ressaltar que está previsto na bula¹ do medicamento pleiteado Aripiprazol, sua utilização para uso adulto, não há indicação aprovada para o seu uso em pacientes pediátricos. Destaca-se que o Autor nasceu em 12 de abril de 2011 (Evento 1_ANEXO2 pág. 1 e 2) e, portanto, apresenta, 13 anos.

Assim, considerando que a bula aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária não abrange a faixa etária da Autora, e considerando que dados de eficácia e segurança para diversos medicamentos utilizados em crianças são escassos¹⁰, neste caso, cumprir complementar que cabe ao profissional assistente determinar de acordo com a avaliação individual e sua vivência clínica, a utilização do referido medicamento.

No que concerne ao valor do medicamento pleiteado, no Brasil para um medicamento ser comercializado no país é preciso obter o registro sanitário na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e a autorização de preço máximo pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED)¹¹.

De acordo com publicação da CMED¹², o **Preço Fábrica (PF)** deve ser utilizado como referência quando a aquisição dos medicamentos não for determinada por ordem judicial e os medicamentos não se encontrarem relacionados no rol anexo ao Comunicado nº 6, de 2013, que regulamenta o artigo 4º da Resolução nº 3 de 2011, e o **Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG)** é utilizado como referência quando a compra for motivada por ordem judicial, e sempre que a aquisição contemplar medicamentos relacionados no rol anexo ao Comunicado nº 6, de 2013.

Assim, considerando a regulamentação vigente, em consulta à Tabela de Preços CMED, o **Aripiprazol 10mg** com 30 comprimidos possui preço de fábrica R\$ 120,39 e o preço máximo de venda ao governo R\$ 94,47, para o ICMS 20%¹².

É o parecer.

À 34ª Vara Federal do Rio de Janeiro, da Seção Judiciária do Rio de Janeiro,
para conhecer e tomar as providências que entender cabíveis.

O NAT é composto por uma equipe de especialistas em saúde pública e para a emissão do parecer foram utilizados e analisados os documentos juntados pela parte autora.

O parecer informou que o medicamento Aripiprazol não apresenta indicação descrita em bula para o tratamento do transtorno do espectro do autismo e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, quadro clínico apresentado pelo Autor, e que o uso seria *off label*.

Aduziu que não há autorização excepcional pela ANVISA para o uso *off label* do medicamento Aripiprazol no tratamento do transtorno do espectro do autismo e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, que o uso da medicação pleiteada carece de evidências científicas para o uso relacionado ao espectro do autismo, mas que para há embasamento científico que respalde o uso do medicamento pleiteado Aripiprazol no tratamento para o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH).

Afirmou que o Aripiprazol 10mg não integra nenhuma lista oficial de medicamentos (Componentes Básico, Estratégico e Especializado) para dispensação no SUS.

Nos termos do parecer, não há diferença significativa entre na comparação entre Aripiprazol e o medicamento ofertado pelo SUS, quando comparada a melhora dos sinais e sintomas do comportamento agressivo no TEA. Para o TDAH afirmou que o SUS não oferta medicamentos.

A tese fixada no Tema 106 do C. STJ é no sentido de que o fornecimento de medicamentos deve estar de acordo com a *“existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”*.

Assim, está ausente a probabilidade do direito pleiteado.

Por fim, considero expressamente prequestionados todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, aos quais inexistente violação.

Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Condeno a Recorrente nas verbas sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mas suspendo em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Publique-se. Intime-se.